BA THÁNG ĐẦU THAI KỲ

THS.BS TRẦN HUY PHAN

ĐỐI TƯỢNG: Y3

NỘI DUNG BÀI HỌC

Chẩn đoán có thai	Tuổi thai-Dự sanh	XH 3 THÁNG ĐẦU TK
➓ Bệnh sử ➓ Khám lâm sàng ➓ Cận lâm sàng	➓ Tuổi phôi/IVF ➓ Kinh chót ➓ Siêu âm	➓ Tiếp cận ➓ EPL ➓ GEU ➓ TT

BỆNH SỬ/CHẨN ĐOÁN CÓ THAI

- Trễ kinh/XHTC bất thường
- Nghén
- Bụng to, Thai máy
- Rối loạn đi tiểu
- Thay đổi ở vú



KHÁM LS/CHẨN ĐOÁN CÓ THAI

- Tử cung to, rạn da, nghe được tim thai, sờ thấy thai
- Dấu hiệu Chadwick
- Dấu hiệu Goodell
- Dấu hiệu Hegar



CLS/CHẨN ĐOÁN CÓ THAI

- HCG/nước tiểu
- HCG/máu
- Siêu âm
- MRI



TUỔI THAI – NGÀY DỰ SANH

- Tuổi thai là tuổi của thai kỳ, tính bằng tuần
- Ngày dự sanh là ngày mà thai đạt 40 tuần
- Thai đủ tháng khi thai được sanh ở tuổi thai 37 tuần trở lên
- Con số PARA

TUỔI THAI – NGÀY DỰ SANH

- Tuổi thai/ngày dự sanh được xác định chính xác nhất trong quý 1 của thai kỳ:
  - Hỏi tiền sử và bệnh sử để định tuổi thai: kinh chót
  - Siêu âm để định tuổi thai: CRL
- Tuổi thai/ngày dự sanh có thể được xác định trong quý 2 và 3 nhưng kém chính xác hơn
  - Hỏi tiền sử, bệnh sử, khám lâm sàng để định tuổi thai: BCTC
  - Siêu âm để định tuổi thai: BPD, HC, FL, AC

TUỔI THAI – NGÀY DỰ SANH

- Tuổi thai/ngày dự sanh được xác định chính xác nhất đối với các thai kỳ thụ tinh trong ống nghiệm
- Tuổi thai/ngày dự sanh được xác định dựa vào kinh chót theo công thức Naegele
- Tuổi thai/ngày dự sanh cũng có thể được xác định bằng việc khám lâm sang (đo BCTC) nhưng kém chính xác hơn



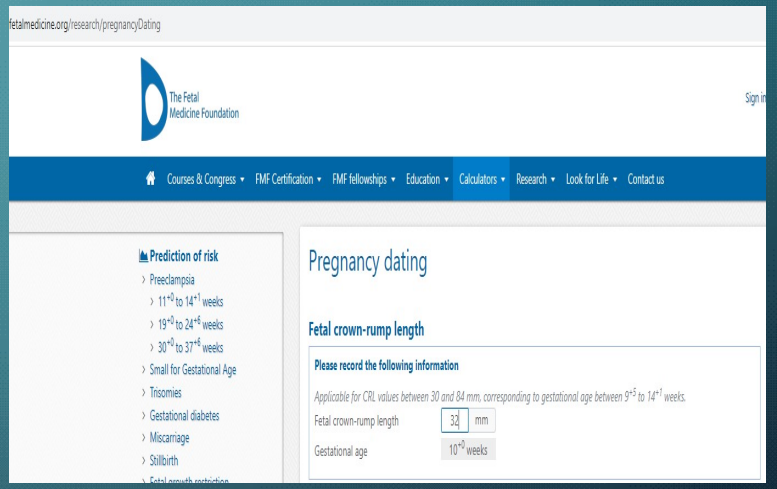
TUỔI THAI - NGÀY DỰ SANH

- Siêu âm xác định CRL là một phương pháp phổ biến để tính tuổi thai ở quý 1
- Tuổi thai (ngày) =CRL (mm) + 42
- Áp dụng khi CRL từ 10-30mm



TUỔI THAI – NGÀY DỰ SANH

- Khi CRL >30mm, vẫn sử dụng CRL để xác định tuổi thai nhưng không dùng công thức CRL (mm) + 42
- Tính tuổi thai dựa vào phần mềm FMF



TUỔI THAI – NGÀY DỰ SANH

- Lưu ý:
  - Để xác định ngày dự sanh dựa vào kinh chót, kinh chót phải thoả tiêu chuẩn nhất định
  - Khi vừa có dữ kiện kinh chót phù hợp, vừa có siêu âm CRL quý 1, nếu ngày dự sanh lệch <5 ngày → chọn dự sanh theo KC
  - Nếu có nhiều KQSA đo CRL ở quý 1 thì nên dung kết quả siêu âm sớm nhất với CRL >=10mm
  - Luôn luôn gắn việc định tuổi thai với đánh giá tăng trưởng của thai

TUỔI THAI – NGÀY DỰ SANH

- Khi hoàn toàn không có dữ kiện để xác định chính xác tuổi thai ở quý 1 → tính tuổi thai/ngày dự sanh theo các dữ kiễn ở quý 2, quý 3 sẽ kém chính xác hơn:
  - BCTC
  - BPD
  - HC
  - AC
  - FL

1. TIẾP CẬN XUẤT HUYẾT TỬ CUNG BẤT THƯỜNG TRONG BA THÁNG ĐẦU THAI KỲ

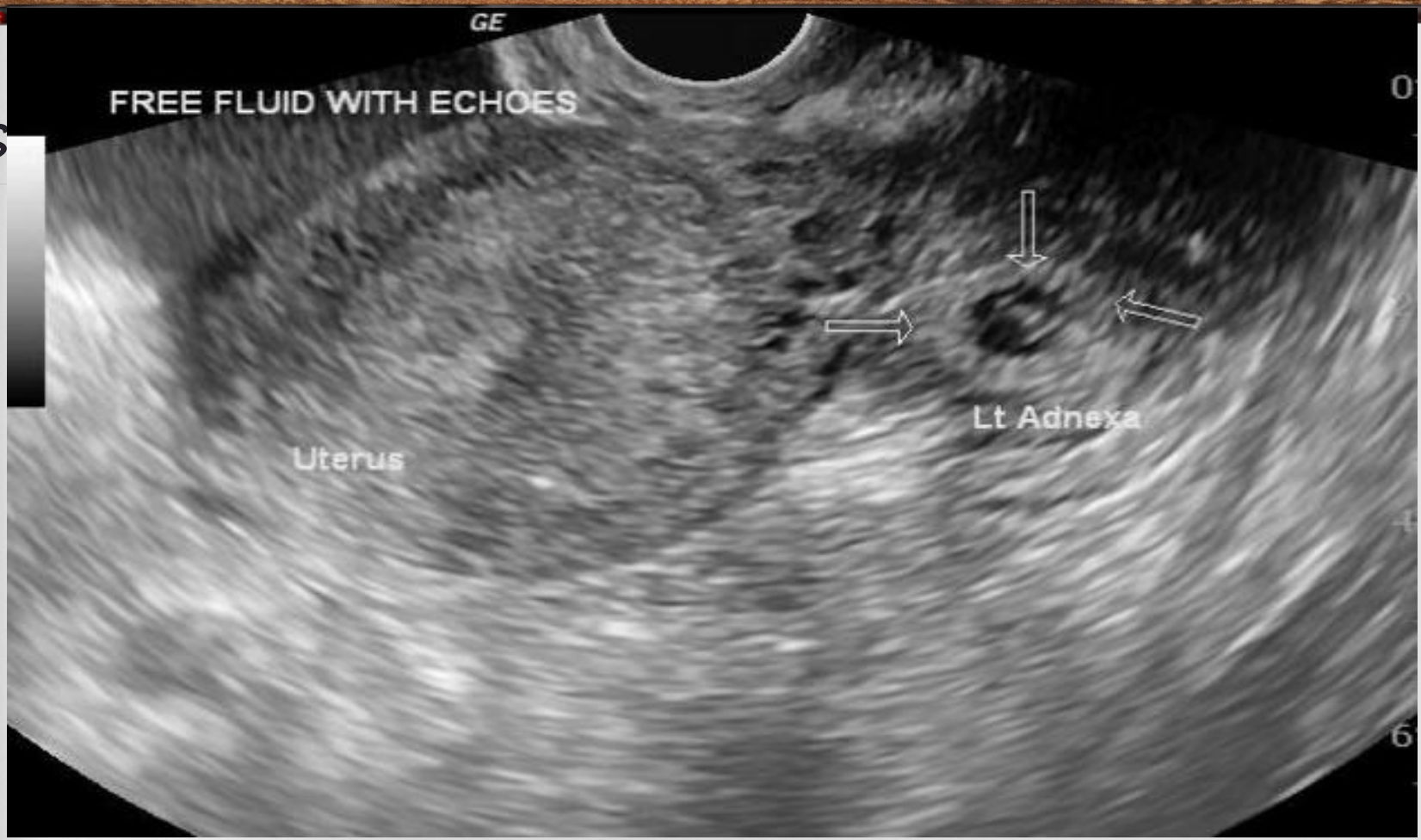
“Câu hỏi lớn của 03 tháng đầu thai kỳ...

HỎI BỆNH SỬ, TIỀN SỬ, KHÁM LÂM SÀNG

- Tìm các YTNC có tính định hướng trong tiền sử
- Những thông tin giúp định hướng chẩn đoán trong bệnh sử
- Khám lâm sàng tìm những thông tin quan trọng cho chẩn đoán nhưng đôi khi lại không tìm được nhiều thông tin

SIÊU ÂM

- Là phương tiện đầu tay
- TVS ưu thế hơn TAS
- Cung cấp thông tin về vị trí của thai, tính sinh tồn của thai
- Một vài hình ảnh điển hình: thai trứng, thai ngoài tử cung sống


GE
FREE FLUID WITH ECHOES
Uterus
Lt Adnexa

ĐỘNG HỌC BETA-HCG

- Thai bình thường, 66% trường hợp tăng gấp đôi (53%) mỗi 48 giờ
- Khi sẩy thai, giảm ít nhất 21-35% mỗi 48 giờ
- Khi đã thấy thai trong tử cung, β-hCG không còn nhiều giá trị

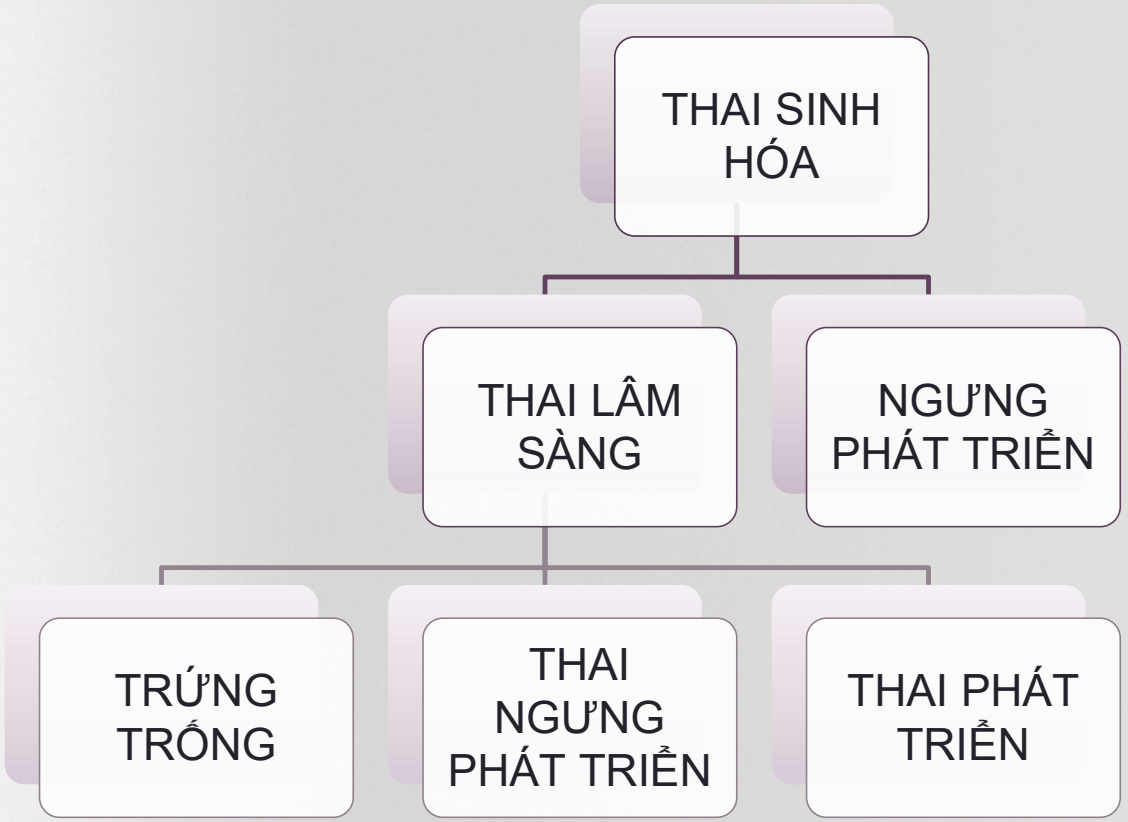
KHÁI NIỆM VỀ NGƯỠNG PHÂN ĐỊNH CỦA BETA-HCG

- Sự kết hợp giữa TVS và β-hCG tạo một ngưỡng phân định để xác định vị trí thai
- β-hCG trên ngưỡng khả năng tìm thấy thai trong lòng tử cung có Sp cao
- β-hCG dưới ngưỡng khả năng bỏ sót TNTC là thấp (Se cao)

KHÁI NIỆM VỀ NGƯỠNG PHÂN ĐỊNH CỦA BETA-HCG

- Ngưỡng cắt được chọn tùy vào điều kiện thực hành.
- β-hCG 1500-2000mUI/ml đối với đơn thai và 3000mUI/ml đối với song thai nhưng không phải là những con số cứng nhắc
- Khái niệm PUL ra đời

2. THAI NGHÉN THẤT BẠI SỚM


THAI SINH HÓA
THAI LÂM SÀNG
NGƯNG PHÁT TRIỂN
TRỨNG TRỐNG
THAI NGƯNG PHÁT TRIỂN
THAI PHÁT TRIỂN

THAI LƯU

- Thai ngừng phát triển trong buồng tử cung.
- Chẩn đoán dựa vào siêu âm
- β-hCG gần như không có giá trị
- Khi thai đã lưu, phải chấm dứt thai kỳ

T



DỌA SẨY THAI LƯU

- Dự báo sẽ xảy ra sẩy thai trên một thai đã hoặc gần như chắc chắn sẽ ngưng phát triển
- Là tình trạng gần như không thể đảo ngược, nguyên nhân thường là lệch bội
- Biểu hiện lâm sàng: đau bụng hoặc ra huyết
- Siêu âm có giá trị dự báo nhưng

DOA


PHILIPS
10/10/2007 04:20:16PM TIS0.3 MI 0.9
LAM
gee Womens RM9
C8-4v/OB Early
FR 56Hz
RS
Z 1.7
2D
72%
C 53
P Off
HRes
M3

SẨY THAI: ĐỊNH NGHĨA

- Sẩy thai là khi thai được tống xuất ra khỏi buồng tử cung trước 22 tuần vô kinh, khi mà thai chưa có khả năng tự sống được.
- 15-20% các thai kỳ chấm dứt bằng sẩy thai với >80% các trường hợp xảy ra trước 12 tuần

CÁC HÌNH THÁI SẨY THAI: TIẾP CẬN VÀ XỬ TRÍ

- Sẩy thai khó tránh
- Sẩy thai không trọn
- Sẩy thai trọn
- Sẩy thai tái phát

XỬ TRÍ THAI NGHÉN THẤT BẠI SỚM

- Các "trục trặc" thường gặp của một thai sớm trong lòng tử cung thường có nguyên nhân: 80% là lệch bội hoặc bất thường NST
- Cố gắng kéo dài thai kỳ này sẽ dẫn đến việc duy trì sự tồn tại của một thai mà khả năng có bất thường là rất cao
- Bạn suy nghĩ gì về "dưỡng thai"???

XỬ TRÍ THAI NGHÉN THẤT BẠI SỚM

- Theo dõi diễn tiến
- Chấm dứt thai kỳ bằng Misoprostol
- Chấm dứt thai kỳ bằng hút lòng tử cung

3. THAI NGOÀI TỬ CUNG

THAI NGOÀI TỬ CUNG

- Thai làm tổ bên ngoài buồng tử cung
- Nguyên nhân gây tử vong mẹ thường gặp nhất trong 3 tháng đầu
- Vị trí
- Xuất độ 1/80



Các vị trí có thể xảy ra thai ngoài tử cung. Thường gặp nhất là ở ống dẫn trứng (vòi trứng). Nguồn ảnh: tudu.com.vn

NGUYÊN NHÂN-YẾU TỐ NGUY CƠ

- Tần suất TNTC gia tăng do liên quan đến những thay đổi trong lối sống
- Thường luôn có một "câu chuyện" đằng sau một trường hợp TNTC



KHÁI NIỆM VỀ NGƯỠNG PHÂN ĐỊNH CỦA BETA-HCG

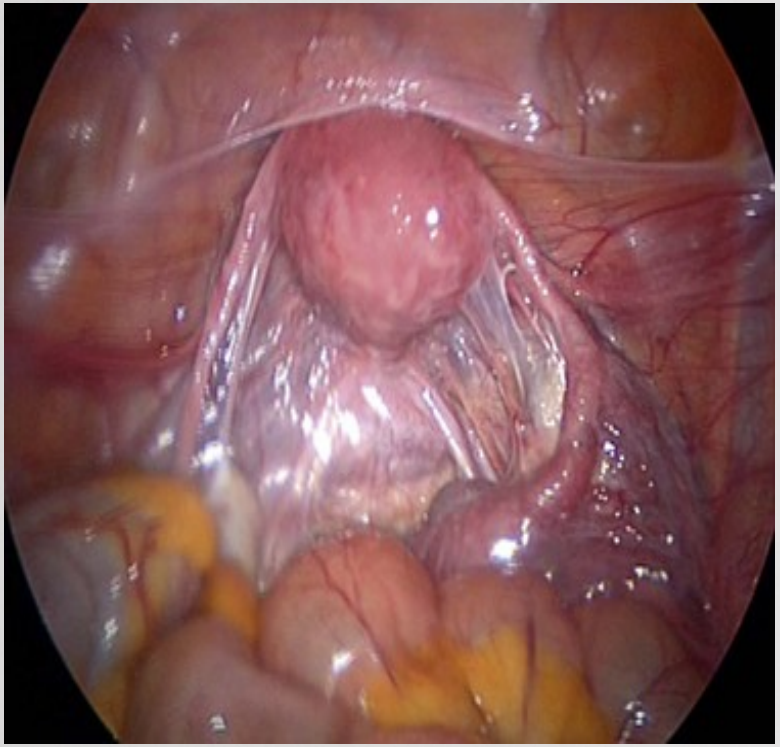
- Sự kết hợp giữa TVS và β-hCG tạo một ngưỡng phân định để xác định vị trí thai
- β-hCG trên ngưỡng khả năng tìm thấy thai trong lòng tử cung có Sp cao
- β-hCG dưới ngưỡng khả năng bỏ sót TNTC là thấp (Se cao)

KHÁI NIỆM VỀ NGƯỠNG PHÂN ĐỊNH CỦA BETA-HCG

- Ngưỡng cắt được chọn tùy vào điều kiện thực hành.
- β-hCG 1500-2000mUI/ml đối với đơn thai và 3000mUI/ml đối với song thai nhưng không phải là những con số cứng nhắc
- Khái niệm PUL ra đời

THAI Ở VÒI TỬ CUNG

- Vỡ vòi trứng → xuất huyết nội
- Sẩy qua loa → xuất huyết nội
- Thoái triển



THAI Ở VÒI TỬ CUNG

- Trễ kinh
- Ra máu âm đạo
- Đau hạ vị
- Khám lâm sàng: có thể sờ thấy khối cạnh TC
- Chẩn đoán phân biệt!!!

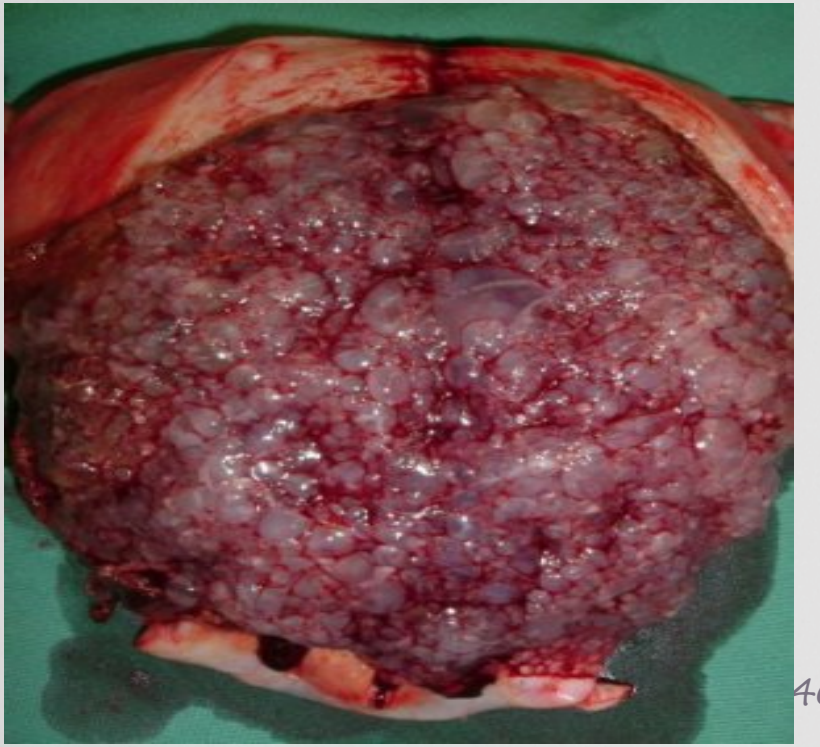
ĐIỀU TRỊ THAI NGOÀI TỬ CUNG

- Theo dõi
- Điều trị nội khoa
- Điều trị ngoại khoa
- Cá thể hóa điều trị

4. THAI TRỨNG

THAI TRỨNG

- Sự tăng sinh bất thường của nguyên bào nuôi
- Là hậu quả của một thụ tinh bất thường có nguồn gốc từ cha → TTTP, TTBP



PHÂN LOẠI

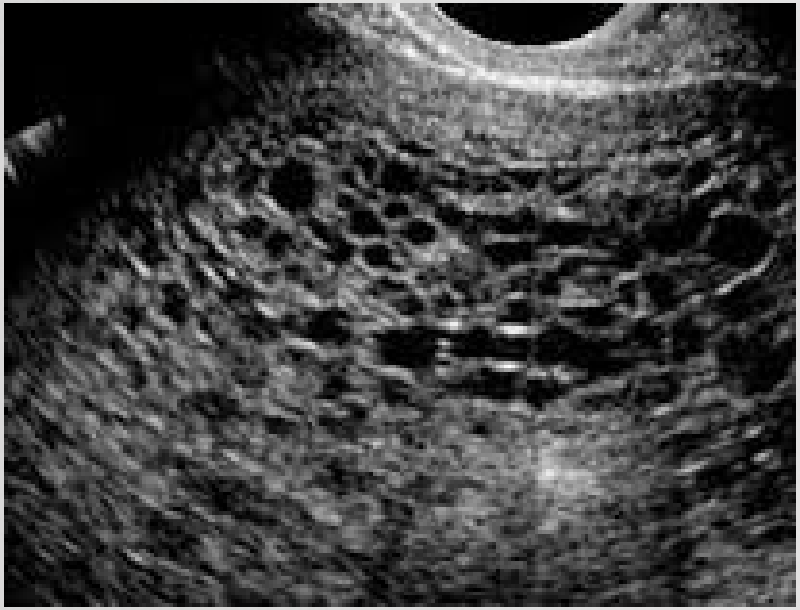
- Thai trứng
- Thai trứng xâm lấn
- Bệnh nguyên bào nuôi tồn tại nơi nhau bám
- Ung thư nguyên bào nuôi

THAI TRỨNG

- Nghén nặng
- Tử cung to nhanh
- Xuất huyết tử cung bất thường
- Các triệu chứng do nồng độ beta-HCG quá cao

THAI TRỨNG

- Siêu âm là khảo sát đầu tay
- HCG là phương tiện theo dõi
- GPB xác nhận chẩn đoán chẩn đoán



THAI TRỨNG

- Hút nạo thai trứng vừa để điều trị vừa là công cụ chẩn đoán
- HCG là phương tiện theo dõi
- Ngừa thai trong quá trình điều trị